

Apartado de la línea de frente:

[00:04]

Personalmente lo primero que le enseñé a una persona es el Bueno, los servicios que brindamos. No sé si es ahorita se lo explico o se lo explico.

[00:21]

Pues en este caso principalmente consultas y explico como tal las especialidades que tenemos y los nombres de los especialistas. Optometría tenemos por fuera, es decir, aquí no se ha consultado optometría. Eh, nuestro oftalmólogo principal es Dr. Luis Giovanni Cárdenas. La subespecialidad ella está como retinología, el Dr. Reinaldo Galué, la oftalmología como el Dr. Francisco Buitrago, estrabismo la Dra.

[00:49]

Mónica Rodríguez, oftalmología el Dr. Juan Carlos Reyes, corneología, esta especialidad únicamente, o sea, la tenemos aquí, tramitamos documentación aquí. Pero los pacientes se ven en la ciudad de Bogotá cuando sea presencial. En el caso de que sea conceptos eh se le realizan exámenes aquí y vía correo electrónico se le envía al especialista.

[01:11]

Ella emite como un concepto valga la redundancia y nosotros le notificamos al paciente cuando llegan los resultados para que vengan aquí con el oftalmólogo a un control. Y también tenemos anestesiología. Está la doctora Claudia Mejía o el doctor Humberto Cárdenas. En el caso de las subespecialidades son especialistas que vienen únicamente una vez al mes, por lo tanto se manejan listas de espera.

[01:40]

Eh, EPS que manejamos aquí con salud, tanto contributivo como subsidiado, son los régimen, Famisanar, eh Cajacopy, FOMAC y teníamos policía, pero ya el contrato terminó y particulares.

[02:08]

Bueno, pues en el caso de línea de frente recepcionamos de todo un poquito, tanto facturación, ingreso de pacientes, también si vienen a preguntar alguna cita, pues les damos la información como tal limitada. ¿Por qué?

[02:23]

Porque pues ahorita como no tenemos citas presenciales, las chicas únicamente están en los teléfonos, entonces nos toca hacer que llamen o a veces cuando ya son casos que realmente si son se nos salen de las manos, nos direccionamos al fijo para ver si nos pueden colaborar con la citina. En el caso de también llegan pacientes para programación de cirugía, la mayoría de la chica no está.

[02:46]

Entonces, nos toca que escriban al WhatsApp o tener más o menos los días que ella está presente para que puedan venir a resolver cualquier duda. En cuanto a línea de frente, nuestro protocolo de saludo como tales, buenos días, bienvenidos. En qué le puedo colaborar y nos presentamos. Y ya ahí continuamos, digamos, si tienen alguna duda, ingresamos a historia clínica con números de documento, a ver si tienen algún examen pendiente, procedimientos.

[03:17]

En ingresos eh recibimos órdenes médicas, los pacientes por lo general llegan en desorden, hasta 2-3 horas tarde, pero nosotros lo recibimos. Nos toca. Entonces Entonces, pues ya recibimos órdenes, verificamos en orden de agendamiento. En el caso de pacientes que sean que vienen de lejos o con casos especiales si tenemos la prioridad.

[03:44]

Eh, manejamos atención preferencial, bebés, pues en este caso adultos mayores, casi no todos son adultos mayores, entonces depende a las enfermedades o condiciones que ellos presenten.

[04:00]

El el sistema es el mismo que manejan arriba, ¿cierto? Es el mismo. Entonces, nosotros como tal tenemos acceso solo a lo que ya está agendado. Por decir, hoy estábamos con el con el Dr. Luis Giovanni Cárdenas, entonces tenemos la agenda del Dr. Luis Giovanni. Procesos, ¿cierto?

[04:23]

Estamos con el sistema de manager. Cada uno tiene sus usuarios, no sé si lo hablo mejor que ustedes.

[04:36]

Nosotros tenemos el sistema de manager. En el caso de las sedes extramurales, aquí aparece Cárdenas visión extramural. Aquí Tunja nos aparece la sede principal. Cada una de nosotros tenemos un usuario.

[04:57]

En línea de frente ingresamos administrativo. a las agendas y la fecha de hoy, la agenda del especialista que es el Dr. Luis Joan. Para la para el ingreso inicialmente tenemos que verificar las plataformas que estén activos. Y en el caso de Famisanar, FOMAC y COSALUD que tengan las autorizaciones vigentes. Posterior a esto creamos las carpetas.

[05:23]

Tenemos carpetas por mes y por convenios. Estamos octubre, nuestra área es asistencial, los convenios. Aquí están todos los convenios. Por ejemplo, un paciente Caja COOPI, tenemos las carpetas por fechas. Hoy 25, estas son las pacientes que ingresé hoy. Todo paciente va a crear carpeta. Primero número documento, después nombre completo.

[05:47]

En la carpeta va la orden que traen para la cita de hoy y la autorización en caso de que la requiera. Ya en el área de abajo ingresan las órdenes y todo lo que sale de hoy nuevo. Una vez tenemos creada la carpeta, marcamos el asistido y vamos a actualizar datos del paciente. En esto verificamos números de documento que algunas veces sale un número mal, EPS es eh todo lo eh general del paciente.

[06:16]

Siempre debe venir con acompañante, ya que hay pacientes que requieren dilatación y y pues esto los deja con visión borrosa. Y incluso a veces se pueden marear. Por eso es tan importante la la acompañante. En este caso, ahorita estamos tomando en la edad porque hay pacientes que vienen con acompañantes que son mayores o inclusive hay Ha habido casos que llega una persona ciega de acompañante.

[06:45]

Entonces, pues no no se puede. La que te decía ya te las recomendaciones importantes que se en el momento de agendar la cita. Que los pacientes entiendan eso, que lo menos tenían pacientes casi en la misma edad de ciegos acompañados. Okay. No sé, lo que hacíamos que el muñequito, que hacer una cosa, que hacer el otro para que el paciente entienda mejor el mensaje, mala tercera edad. Listo.

[07:12]

Es Esta es la línea de frente, esta es la entrada principal de todos nuestros pacientes. Y de acá ya pasan a la consulta. Estos son los puestos que una rota. Porque acá se siente la presión. Sí, la cantidad de pacientes que se Acá están todos firmando con sentimientos, ella revisando el paquete. ¿Viste lo que hace todo ella?

[07:39]

Y digamos cuando tú iniciaste más o menos cuánto te tardaste Pasaste más o menos a estabilizar lo que tienes que hacer aquí. En mi caso ¿Y qué fue lo que más se te dificultó? Lo que más se me dificultó fue en el caso de la facturación porque, digamos, en el número de las autorizaciones son a veces números repetidos, a veces se me dio un número más, un número menos y en los copados.

[08:08]

¿Qué te parece la recepción al copago? En el caso de co-salud, pues, las autorizaciones algunas personas vienen, como por decirlo así, mal diligenciadas, vienen con error. Entonces, me toca directamente verificar en Cruz Salud.

[08:20]

Al principio nos nos no tenía como tan claro eso y me guiaba solo por la autorización y no por la plataforma y se podía cobrar más, se le podía cobrar menos o inclusive a pacientes que eh se les cobraba menos y al verificar finalmente en la plataforma Lo que pasa es que acá es importante que el paciente tiene que saber de todo.

[08:52]

Tiene que saber cuál es el contrato, cómo está contratado, cuánto se le cobra al paciente, qué régimen es, ver la autorización. Las plataformas se equivocan. Entonces, nos toca estar pendientes, hacer todos los filtros acá.

[09:04]

Para saber las chicas casi todos los perfiles de acá son de la de la enfermería, porque acá también se hace unas anamnesis, qué qué medicamentos tiene, cómo qué patologías trae, si han sido operados, información muy privada que se acá se tiene que hacer esa recolección de esa información. Entonces, son muchas cosas en menos de 1 minuto. El buscar eso rápido. Sí. ¿Y más o menos cuánto tardaste en tiempo para aprender eso?

[09:35]

O sea, aprender todo lo que me cuesta el tiempo. Pues inicialmente cuando llegué aquí entré a consultor y como digitadora Una semana y después se hace inducción práctica inducción práctica inducción práctica inducción práctica pero eso hace reproceso para la otra persona.

[10:03]

Pues porque realmente es En este momento estamos gastando más o menos 8 minutos en el ingreso de cada paciente. Y es un ¿Cómo te digo? Para aprender sí es un poco complicado porque es entra aquí, entra aquí, entra aquí No, señora, ya terminamos.

[10:46]

Aquí en este módulo aquí se ingreso las autorizaciones y también debemos juntar, digamos, cada copia y no requiere autorizaciones para mis ana, tiene una nueva vigencia de 60 días, pero como nosotros tenemos usuarios que nos dejan autorizar en este mismo momento. Los auto Los pacientes traen las preautorizaciones, nosotros en la plataforma la autorizamos.

[11:09]

Eso tiene una vigencia de 60 días, pero en la en la en el acceso de la autorización facturamos fecha inicial, fecha final hoy. ¿Cómo salimos? Ya la fecha inicial trae la autorización, ellos me traen impresa y Y la fecha final más o menos la calculamos 90 días. Sin embargo, aquí no la cuenta porque a veces nos da 91, 89 y entonces aquí nos ayuda con el conteo con max en 120 días.

[11:36]

Entonces todo eso lo debemos tener en cuenta para ingresarlo fecha inicial, fecha final. Aquí únicamente ingresé la autorización.

[11:49]

Aquí únicamente ingresé la autorización. Ahora voy a admisionar. En el caso de Caja Copy únicamente admisión. Ya con las otras EPS debo aquí ingresar nuevamente en el caso de nuevo. En el muñequito si no quedan bien actualizados los datos, aquí me va a generar otra tarifa y ya genera el error.

[12:12]

Entonces nuestro vendedor siempre es Sergio, tipos de pago en todos los pacientes es autorización, a excepción de los particulares que siempre es efectivo. O sea, esto no no cambia mucho. Centro de costos, depende en la sede en la que estemos, en este caso. Pon a La tarifa siempre está precargada, lo que te decía si si en la actualización de datos cometes el error, toda la historia y toda la la paciente te queda con error.

[12:40]

Prefiero En este caso utilizamos los precios F, O R y RC. F es para los particulares, O R es para los pacientes que no deben cancelar ningún costo y RC es cuando entra dinero a la caja. En el caso de autorización, aquí no me carga ninguna autorización, pues porque antes no la ingresé.

[13:02]

Automáticamente Apenas ingresa la autorización y se guarda, me va a aparecer Entonces le damos ver autorización, aquí me da el nombre del procedimiento, le ponemos chulito y la abogamos aquí con el con el nombre del médico y las cantidades.

[13:21]

Tenemos que estar tenemos que estar muy pendientes también de las cantidades cantidades porque en las EPS por lo general si se envía un examen para ambos ojos autorizan cantidad de uno y le dejan de observación ambos ojos. Eso no se puede pues porque estamos hablando de dos ojitos que haría facturado solo cantidad uno y en los seguimientos que nos hacen las EPS nos quedaría todo mal.

[13:45]

Una vez actualizados datos, ingresado autorización y admisión vamos a abrir historia clínica.

[13:55]

Entonces, aquí ponemos lo que refiere el paciente, por en el caso de hoy venían exámenes, entonces ellos siempre dicen, "Vengo un examen." Pero nosotros debemos especificar si es de uno o de ambos ojitos. Siempre en tercera persona entre comillas porque es pues como lo que dice el paciente. En el subjetivo explicamos a qué viene. Entonces, en este caso todavía estamos manejando lo del protocolo de COVID-19. Entonces, preguntamos cuántas dosis de la vacuna del COVID tiene.

[14:25]

Eso se hace por historia clínica y por norma para todo. Son pastillas ya preelaboradas ahí. Entonces, aquí viene realización, le escribimos el al procedimiento al que viene, especificamos el ojo. Siempre debemos poner el nombre del acompañante, la edad, el parentesco y si viene solito, camina solito con bastón, en silla de ruedas.

[14:54]

Y también en el En este caso los oxígeno requirientes, lo especificamos aquí. Antecedentes. En el caso de los antecedentes, preguntamos cirugías generales, cirugías que hayan tenido oculares, medicamentos tópicos como cremas, etcétera, farmacológicos, todos los medicamentos que toman, eh traumatismos oculares. Bueno, esto ya es en caso de que hayan tenido golpes, hayan perdido los ojitos, etcétera.

[15:23]

Alergia a medicamentos. En el caso de farmacológicos y quirúrgicos generales tenemos debemos tener en cuenta los pacientes con cardiopatías y enfermedades respiratorias, ya que aquí como realizamos dilatación de Hay un medicamento que les puede afectar y hay otro que no, entonces debemos siempre tener en cuenta la fórmula de medicamentos para saber aquí de igual manera qué tipo de gólicas se les puede aplicar.

[15:49]

Antecedentes familiares como hipertensión, diabetes, enfermedades, eh ¿Cómo se dice? ¿Hm? Genéticas. Aquí antecedentes patológicos oftalmónicos, digamos si un paciente ya fue operado de catarata, le marcamos la catarata porque ya tuvo el antecedente. y así con los demás diagnósticos. Fuma, toma eh psicotrópicos u otros.

[16:14]

Estos siempre los llenamos porque en el caso de una anestesia un paciente si consume alguna sustancia alucinógena, la la anestesia es es resistente a la anestesia.

[16:26]

En el caso de las consultas de anestesiología eh el área de call center debe pedirles historias clínicas de medicina general y deben traerlas por fórmula médicas, porque realmente los pacientes a veces no dicen la verdad o solo saben que sufren del corazón, pero no saben la historia de qué más tiene.

[16:48]

Entonces ya la especialista le revisa toda la historia y así le ha visto bueno o no a la anestesia. Ya en este caso es ese es el proceso de línea de Ese es el primer paso que se hace para continuar con la consulta. Entonces, para poder ellas hacer este tipo de la mesis tiene que conocer y tratar mucho con el paciente, deben tener mucho carisma, paciencia.

[17:14]

Y eso lo que tú te se entiende especial la hora de inducción tiene que ser paso a paso concreto. Para que abran gas, porque nosotros podemos durar hasta 15 días dando inducción acá y si ellas llevan cuántos años estudias? Dos. Y comete sabías errores. La verdad.

[17:34]

Hm, ¿cuántos profesionales trabajan con usted? De 5 especialistas 2 7 8 oftalmólogos y su especialista 8 diferentes Sí, para cuando vayamos a hacer como el manual que cada uno tenga su nombre específico, su especialidad, etcétera.

APARTADO DE CALLCENTER:

[01:30]

Bueno, pues es que ayer hablamos con pues la gente Sí. y pues tenemos unas preguntas que ayer ella nos O sea, dijo que nos podía facilitar como unos protocolos de cada persona, de cada rol que tiene la cada persona con un momento de capacitar. Okay. Pero entonces, bueno, hoy no se atienden llamadas. No sé, digamos que es lo que Hoy estamos respondiendo lo que es correos y WhatsApp.

[01:56]

Digamos que que por ejemplo, cuando una persona llega Sí. eh nueva, o sea, un empleado. Sí. Eh, digamos que es lo que se le enseña, que Ah, okay. O sea, vamos a asumir que ustedes van a asistir al área de call center y que son personas nuevas. Sí. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Sara Porras, yo soy la coordinadora call center y en este momento también aprendí cena. Entonces, en el área de call center nosotros tenemos cuatro canales de comunicación.

[02:27]

Tenemos el canal que es vía telefónica, que es una línea que es el 333 033 32 52. Por ahí solamente respondemos llamadas. La hora de atención de esas llamadas nosotros las respondemos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4. Eh, también tenemos el canal de WhatsApp, que es un número específico que es el 316 751 5178, de igual manera en esos horarios, de 8 a 12 y de 2 a 4.

[02:56]

Tenemos correo y tenemos una línea eh alternativa para una entidad específica, que es vía WhatsApp o vía telefónica, que es para la entidad de Pumaca. Que te comento yo, bueno, pues acá nosotros agendamos nosotros como netamente el área de oftalmología general, subespecialistas y exámenes. Para programación de cirugía ya hay una línea especial que está una compañera aparte.

[03:20]

Entonces, pues nosotros normalmente pues recibimos los correos o la o los mensajes vía WhatsApp y depende de nuestra agenda, bajo lo que nos indican los especialistas cuando vienen, cuando asisten, estamos agendando los pacientes. Normalmente tenemos eh las subespecialidades una asistencia del especialista por mes. Manejamos lo que es glaucoma, retina, estrabismo, eh orto óptica, eh ¿Cuál era la otra?

[03:49]

Corneología, pero esa no es acá en Tunja, sino esa se mandan a los usuarios a Bogotá directamente. La especialista en estrabismo asiste una vez cada tres meses. Nuestros especialistas sí están asistiendo una vez por mes y también anestesia. Anestesia contamos con dos especialistas, la doctora Mejía y el doctor Juan Humberto. Entonces ellos nos van a a nosotros habilitando, digamos, eh un mes anterior como en qué fecha van a asistir.

[04:16]

Entonces, digamos, por cada especialista también tenemos un límite de pacientes, pues depende de la jornada que ellos asisten. Eh, que te comento, digamos, en este momento disponemos de agenda habilitada para especialista en la oftalmología el día 4 de noviembre, el 8 de noviembre tenemos valoración por glaucoma. Y en retina tenemos el 14 de noviembre.

[04:41]

Durante la durante el mes nuestro especialista y él también director científico, que es el doctor Giovanni, dueño de la empresa también, eh de parte con la doctora Paola. Él es el que más constantemente se encuentra acá en la clínica. Él atiende fijamente aquí en Tunja lo que es los días

miércoles para consulta y controles de cirugías y los días martes él está realizando cirugías siempre acá en la clínica. Ya el resto de los días de la semana va variando depende de la sede.

[05:11]

Contamos con una sede es en Moniquira, Chiquinquirá, Tuitama, Sogamoso, Samacá y Acatá. Acatá es la sede principal. El doctor Giovanni, él se está trasladando en este momento a las demás sedes para la valoración de parte de los municipios que te acabo de indicar, ya que pues se están agendando los municipios aledaños a esas sedes. Eh, ¿qué más te digo yo? ¿Qué más les comento?

[05:37]

Eh, valoración para toma de exámenes lo realiza solamente una compañera. Ella lo realiza comúnmente lo que es los días martes y los días sábados. Ella realiza todo el tema que es de exámenes, que son como ayudas diagnósticas y también imaginología. Mmm, ¿qué más te comento así del área de call center? No sé si de pronto quieran ver cómo nosotros respondemos los mensajes. Sí, sí, sí. Bueno, ella en este momento está en WhatsApp y yo estoy acá en correos.

[06:08]

Entonces, nosotros normalmente nos llegan correos de pacientes o también directamente PQRs o tutelas. Entonces, en este momento, digamos, yo cuento con 63 correos, de los cuales pues no puedo darles respuesta por algún motivo en especial. Hay usuarios que solicitan cita para una especialidad y digamos todavía no tengo habilitada la agenda, entonces yo no tengo, digamos, resaltado con esta banderita para tenerlo presente en la próxima jornada.

[06:34]

Digamos, en este caso, uno de los últimos que fue el día de hoy. Entonces, este paciente solicita una cita de control con retina. Entonces, él nos indica pues los datos básicos de él, nosotros copiamos el número del documento y en el sistema nos dirigimos a leer como está la historia clínica de él, de qué proceso ha llevado con nosotros y qué cita requiere. Nosotros para todas las entidades, eh excepto Cajacopy.

[07:00]

Ah, contamos con cuatro entidades en este momento con servicio, que son las entidades Omac, Cajacopy, CoSalud y Famisanal. De de esas cuatro entidades nosotros debemos darle una prioridad. En primer lugar, a FUMARC, en segundo lugar, a Cajacopi, en tercer lugar, a Famisanar y en cuarto lugar, a Coosalud. Con todas las entidades requerimos autorización, excepto con eh Cajacopi.

[07:24]

Ya que Cajacopi tenemos un tipo de contrato PGE PGP, ya que con ese contrato no requerimos autorizaciones y digamos, con ellos tenemos un presupuesto designado por mes. Con las otras entidades tenemos un presupuesto libre. O sea, digamos, con Cajacopi tenemos que agendar cierta cantidad de pacientes para determinadas No, para determinadas ¿Cómo se le dice? Agrupadores, se les dice.

[07:53]

Los agrupadores se dividen en tres, que son imaginología, apoyo diagnóstico y cirugías. Eso lo comparto con la chica de programación de cirugía. Y ya con ella eh digamos estamos en contacto para saber qué ha programado ella y qué he programado yo, para saber qué no nos pasa hacemos el presupuesto que tenemos designado ni tampoco estar sobre debajo de él. Es con la única entidad.

[08:17]

De resto ya lo que es FOMAC, eh Famisanar y COFODESALUD y así digamos podemos agendar, pues a medida que los usuarios van solicitando los servicios. Eh, que bueno, entonces íbamos con el paciente Laurentino. Él, por ejemplo, cuando acá nosotros verificamos la entidad, en este caso, él es una entidad particular. Él tuvo una valoración el día 29 de septiembre y en esa valoración los problemas que le dijo el especialista, que fue atendido por el Dr.

[08:46]

Giovanni, el oftalmólogo general, y él le solicita un control en 6 meses y él fue atendido en el mes de septiembre. Entonces, vamos a mirar qué más pudo aparte de eso.

[09:05]

Aquí en esta parte nos aparece, digamos, todas las consultas que él la tenía. Y por lo que, digamos, yo más o menos me dio por todas las asistencias que ha tenido y por la antigüedad que él lleva viniendo desde una historia desde el 2024, él tal vez tomó una cita particular, pero él debe pertenecer a una entidad de las que tenemos afiliados. Y ya ahí pues nosotros nos iríamos directamente al la DRE y confirmamos en qué entidad él está afiliado.

[09:33]

Y ya depende de eso le preguntamos si se requiere todavía el servicio. De manera particular, pues si lo requiere por medio de EPS.

[09:45]

Él pertenece a familia sana. Entonces, él te pronto toma un servicio particular para agilizar el proceso que llevamos. Entonces, dice anteriormente Él tiene un control con glaucoma.

[10:25]

Entonces, bajo la historia de los días anteriores que él ha asistido, él lleva un control con glaucoma. El día 10 de agosto, Hola, buenos días. el día 10 de agosto el doctor el oftalmólogo le solicita control en 6 meses. Después el 17 de septiembre asistió con el doctor Giovane y le solicita un control el 29 de septiembre, pero este día 17 de septiembre.

[10:53]

Entonces, solamente me pongo Pero ¿Qué se hizo?

[11:08]

Aquí en el diagnóstico nos aparece, digamos, lo que es el Acá nos aparece POP de vitrectomía posterior. Esto es una cirugía. Entonces, lo más probable es que él tuvo una cirugía antes del control con glaucoma.

[11:28]

La tuvo la cirugía en el mes de en el año pasado en el mes de diciembre. Entonces, este control que tuvo el día 17 de septiembre fue el control de la vitrectomía y ya le solicitan un siguiente control el día 29 de septiembre y en ese control le solicitan un control en 6 meses.

[11:48]

Entonces, bajo la orden médica que yo veo de él, él requiere controles dentro de 6 meses y En el correo lo retiro el solicitud respecto a un cita de control con retina. Él está solicitando un control con retina. Pero entonces no estoy de acuerdo la que no me está dando por la última vez.

[12:35]

El día 12 de abril tuvo la último control. Con el retinolo vi ese día fue cuando estuvo cerca la cirugía de mi tiroides mía, pero entonces el control se lo solicita exactamente en 6 meses de abril. Mayo con el mes de septiembre, octubre. Entonces, en el mes de octubre y nosotros ya tuvimos cita con retinó. Entonces ya nos toca programar la cita dentro de la próxima agenda que tenemos.

[13:04]

La próxima agenda que tenemos de retina es el día 14. Entonces como ya había visto que él pertenecía a Family Sanar, voy a decirle si él tiene autorización para poder agendar la cita. Si él no la tiene, nosotros la podemos generar acá antes de que tengan la cita.

[13:29]

¿Eso es muy raro o hasta el momento todo está claro?

[13:38]

¿O hay alguna pregunta de algo en específico?

[13:45]

¿O hay alguna pregunta de algo específico? Eh, hay unas propuestas al final después del todo el inicio.

[13:57]

Para nosotros verificar las autorizaciones de los pacientes tenemos tres plataformas, bueno, cuatro plataformas, una por cada entidad. Por ejemplo, esta es nosotros la Nosotros pues al ingresar a la plataforma, acá nos vota el registro de todas las autorizaciones que el paciente ha tenido o que tiene pendientes para las consultas que él vaya a solicitar. Nosotros tenemos en las autorizaciones tres estados, uno que es radicada, otro que es eh direccionado y otro que es autorizado.

[14:27]

El estado de erradicada es que nosotros ya generamos la solicitud de la autorización, pero todavía no se puede hacer uso de ella para poder prestar el servicio. Normalmente las direccionan eh después de radicada 5 días, pues es el tiempo estimado que se debe hacer, pero hay veces que se demoran más o se demoran menos, pero nosotros debemos verificarles que todas las autorizaciones para prestar un servicio estén direccionadas.

[14:55]

ya que ese es el que nos identifica de que ya eh la autorización fue aceptada por la EPS y en el estado en el que está autorizada es cuando ya se utilizó. Entonces, digamos, esa autorización ya no se puede volver a usar en ninguna otra ocasión.

[15:08]

Y en este caso el paciente Laurentino tiene direccionada una autorización, verificamos que también está direccionada a la EPS que corresponde que está solicitando la cita, que saca en este caso a nosotros Cardenas Visión y efectivamente tiene una consulta con retinología. Entonces, con esa autorización nosotros vamos a agendar ya la cita. Y pues se la agendamos el día que tenemos disponibilidad. Con el doctor tenemos el día 14.

[15:42]

También necesitan mirar el paso a paso cómo se agenda, o sea, el sistema. De que dinero y datos. Sí. ¿Podemos hacer una foto ya? Sí. Sí, pues lo dejo ahí. Sí. Y ya ahí ponemos la fecha de la persona que ha ido a la cita y la hora.

[16:17]

Y ya después de haber agendado la cita en el en la fecha que correspondía, solo le enviamos al paciente una plantilla con el recordatorio. Entonces, en este caso Ay, pero verdad, él estaba con otras entidades. A él nos toca cambiar la entidad porque él la va a solicitar por medio de la EPS. Pues en este caso me toca dirigir el usuario. Ah, sí.

[16:52]

Siempre que vamos a editar el usuario que pertenece a una EPS, tenemos que verificar si él es contributivo o subsidiado. Y de igual manera, en la plataforma de la EPS nos nos muestra sobre si es contributivo o subsidiado y sobre que nivel está también.

[17:10]

Y él es contributivo beneficiario nivel Y eso también toca dejarlo digamos todo anexado acá en el sistema, pues como para el tema de facturación. Depende todo de de parte del área donde se agenda la cita, como se facture allá abajo.

[17:37]

Y ya sí, después de que cambie pues unos datos, ahora se agenda la cita. Que siempre que vaya a quedar agendada la cita, que si él desea tomar la medida de la cita de manera particular o por un plan que corresponda.

[18:08]

Ahí nosotros siempre ponemos aquí como una nota porque medio se agendo la cita. Entonces, en este caso como que es por correo, yo solamente pongo la nota que es por correo porque hay veces que los usuarios no al momento de asistir a la cita dan una información incorrecta, eso de que a veces hay un poco de Aló.

[19:02]

Confírmame el número de documento del paciente. Sí.

[19:15]

Dana Ginette Albarracin. Eh, no, no, señora, no tiene ese agendado.

[19:32]

Ella le envía la plantilla con el recordatorio y la fecha de la hora que tiene agendada la cita. Eso por medio correo. Algo similar es por WhatsApp, pero entonces en WhatsApp nosotros solicitamos los datos los hijos del paciente. No, señora, no, señora, no necesito No sé para eso es lo que requiere. Entonces, eh pues no tienes así nada como ha dicho que existe una vez por mes por la parte de córnea y en la parte de estrabismo, no están como en las citas.

[19:59]

Cuando se trata de córnea, eh nosotros mandamos a los usuarios a Bogotá. Cuando se mandan a Bogotá es para cita presencial. Con eh cuando ellos se le cita presencial en Bogotá, se le solicita autorización si es favorable a co-salud. Y antes de tener una cita presencial, a ellos se les pide unos exámenes. Esos exámenes se llaman ventaja y en valoración por optometría con los enciclopedias. Primeramente ellos tienen que tomarse de sus exámenes para ir a cita presencial en Bogotá.

[20:30]

Cuando ellos tienen cita presencial se solicita autorización. Y cuando el especialista ya los valoró y vio los resultados de los exámenes se llama concepto. Ese concepto también se factura como si fuera una cita presencial, pero en realidad no es. Entonces cuando tienen el concepto, nosotros facturamos como si fuera una cita normal Y cuando ella nos llega con el sistema, que digamos hay

un un intermediario que es una compañera asistencial, ella se comunica con la especialista y ella nos indica que ya hay el concepto.

[20:59]

Nosotros comunicamos al paciente para que solicite una cita por oftalmología para que el oftalmólogo lea el concepto. Entonces, hay como que se facturaría una cita sin se se preste. ¿Te acuerdas de una topo y una paquita que estamos en este cita No. Aló. ¿De una copia? No, no son muy Para esto Y el especialista en estrabismo asiste una vez cada De la 3 meses.

[21:30]

Entonces, ella es la doctora Mónica Valero. Dime. Como ella asiste cada 3 meses 10 y y el oftalmólogo a veces Luego utiliza usuarios durante las atenciones que tiene durante los ¿A meses? quién a estrabismo Nosotros qué hacemos Tenemos una lista de espera en un excel en entrar.

[21:46]

En esa lista espera, tenemos todas las Y a medida de que nos van solicitando las citas, vamos dejando el usuario, los datos del usuario, el número de teléfono, la entidad a la que pertenece y el municipio y el servicio que solicitan. Entonces, digamos en el área de trabnología. Esas especialidades están cada tres meses.

[22:14]

Lo dejamos acá por entidad y hay un un montón de colorcitos. Esos colorcitos nosotros los identificamos como prioridades. Entonces, acá pues por lo menos ponemos la fecha en la que solicita el servicio. Deberíamos poner la fecha de la orden médica de cuándo lo requiere y los datos básicos. Vamos por lo menos yo. Yo digamos como que lo manejamos las tres. Yo manejo el color este azul celeste para resultar que es una cita prioritaria.

[22:43]

Pero entonces, la última vez que tuvimos cita con este especialista fue en el mes de octubre, el 12, ella asistió un domingo y eh bajo los pacientes que ella tiene la jornada no alcanzó a pasar todos los usuarios, entonces ella es una paciente prioritaria de COFESO que tenemos que darle respuesta bajo PQR.

[23:04]

Entonces, cuando la doctora vuelva a asistir, tengo que sí o sí agendarla a ella, a este paciente y a estos que son rojitos también es que han comunicado constantemente y pues no le hemos podido digamos como agendarla así.

[23:19]

Igual de Mira, también cuando nosotros los llamamos para agendar, les indicamos en la fecha que tiene la cita, pero a veces o no contestan o no pueden tomar la cita, dejamos la observación porque a veces pues los usuarios son un poco complejos y dicen que nunca se deshace de una cita, pero no contestan los teléfonos o no toman la cita. Eso pasa con todas las entidades. Entonces, creo que hasta el momento sería la gran mayor parte de eso. Okay. No sé si tienen dos.

[23:50]

Bueno, eh, es una duda que pues es un poquitico aparte del proceso del proceso y es el cómo tú te sentiste cuando hiciste cuando llegaste por primera vez, o sea, ¿te llegó mucha información, te diste a broma o?

[24:04]

Pues yo sé que ahorita fui muy rápida y entregué también toda la información así demasiado, pero pues no, la verdad no, porque digamos, cuando yo llegué, pues yo soy aprendiz de Cuando yo llegué la persona que estaba de coordinadora, ella me dio como una inducción mientras estaba laborando. Entonces, ella me indicaba lo mismo. Nosotros tenemos tantas plataformas, tantas eh pacientes, tantas EPS, tantos contratos.

[24:30]

Y ya fue en el transcurso de la semana que ella me fue soltando, digamos, como la voz. Entonces, el primer día yo solamente estuve con ella en línea de frente.

[24:39]

Con ella me decía como que, "No, tú solo ve recepcionando al paciente que si te requiere y la diriges con la chica que pues le puedas resolver la solicitud." Yo durante el transcurso de semana ella me iba designando más tareas muy suavemente y pues yo las iba a resolver y siempre siempre que tenía alguna duda siempre que no estaba segura de algo yo le preguntaba y ella me resolvía la duda. Pero ¿Ese proceso para poder aprender todo?

[25:09]

Yo todavía sigo aprendiendo. Porque digamos en la parte de leer las historias clínicas de los pacientes hay mucha terminología que yo desconozco. Y digamos hay una que ya conozco pero ha sido por la experiencia. No es de porque yo me haya puesto a estudiar, sino por la experiencia y siempre que tengo una duda también en el personal asistencial, yo les pregunto si agendar esa cita está bien o está mal o si requiere otra cita y ellos me sacan de la duda.

[25:35]

Digamos como en la parte de si me llego a equivocar no puede ser netamente como mi culpa porque siempre hay alguien que me pueda ayudar a resolver la duda. Y pues hasta el momento he aprendido, pero digamos lo básico como tal en el área de conciencia Yo creo que me voy a morir por unos 3 meses. Okay. Y ah, bueno, otra pregunta. Digamos que pues O sea, tú llamas a las personas, ¿no? Y esas personas ponen a las personas mayores, ¿no? Mhm.

[26:02]

Eh ¿Cómo se ¿Cómo es el trato a las personas de pues De nosotros hacia ellos o cuando ellos nos llaman. Bueno, los tipos de reacciones que se tiene, que se tiene que tener. Pues, digamos, nosotros normalmente siempre comunicamos al paciente, le nos dirigimos y nos presentamos por salud cuando vamos a agendar una cita y ellos no nos llaman. Entonces, nosotros los saludamos como que buen día, buena tarde, nos comunicamos de parte de Carteles Visión, mi nombre es Sara. Eh, yo lo comunico por el motivo de que tiene una cita pendiente.

[26:31]

Vamos a agendar la cita que tenía el control de, no sé, de una cirugía, que eso lo estaba haciendo ahorita con unos de retina y ellos nos indican que sí. Pues normalmente ellos son como, ah, que sí, que pues eh si tenían la cita pendiente, nos indican sobre qué fecha, sobre qué hora. Nosotros le damos una hora sobre qué queda cómoda los tiempos, porque ellos solo escriben muy lejos y pues no pueden asistir muy temprano.

[26:54]

Entonces, pues nos tratamos de acoplar un poquito a eso, aunque a veces es un poco complejo y ya les damos las indicaciones y recomendaciones como que asistir con acompañante, orden médica, autorización y disponibilidad de tiempo. Siempre, siempre se les pide eso a a los usuarios, disponibilidad de tiempo y acompañante. Y de igual manera, por llamar, entonces ellos se comunican y nosotros decimos como que buen día, se comunica con Sara Porras de la sede de Tunja en que le puedo colaborar. Aquí ves.

[27:25]

¿Lo más del protocolo? ¿Qué necesitamos a ver? Pues prácticamente todo lo que ¿Quién nos dijo? Yo, perdón, toda pregunta, ¿para qué es la Es que la idea es como automatizar un poco el No, el tema de la inducción a los nuevos trabajadores del área Sí. de call center Okay.

[27:46]

Es como para evitar que sean tres meses y no de pronto sin la necesidad incluso de una persona que les esté enseñando, sino que todo sea O sea, todo ya esté también documentado y de una forma como bastante fácil de aprender que ustedes lleguen y como que vayan utilizando el manual mientras van trabajando y y desde ahí vayan aprendiendo todo si no se hace algún tercer. Bueno, cuando yo llegué Cuando a mí me entregaron el área de call center, pues mi compañera me entregó, digamos, todo lo básico.

[28:16]

Yo eso nunca lo he aplicado y tampoco nunca lo he entregado, pero yo lo encontré a ella así que era como un digamos como un documento así chiquito. Con eso. Pero entonces no sé si esté muy completo o no. Este.

[28:34]

Eso lo tenía ella, yo nunca lo he usado y eso tampoco lo hice yo, pero entonces no sé si si este es muy completo o si falta todo lo que porque pues a la final son cosas que en sí se aprenden más que todo es con el tiempo y bajo la experiencia.

[29:17]

¿Qué más sería?

[29:25]

Eso es en cuanto acá colcenter. Sí, ¿cómo no es área, ¿no? Sí. Cuando nosotros, bueno, es que call center estaba también tanto como en llamadas como en línea de frente, pero ahorita por un colapso un poco de pacientes que hemos tenido nos dejaron solamente en el área de call center porque atender a todos los usuarios de manera presencial un poquito complejo porque eran demasiados y no teníamos el abasto pues de citas para agendarlos.

[29:53]

Entonces, ahora solicitamos que pues nos comuniquen por los canales de atención. Entonces, no sé si de pronto en el área de línea frente, no sé si de pronto van a habilitarla en un futuro nuevamente. O si se va a mantener así.